

RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN

Alberto Ibáñez Ibáñez, Patricia Camino Marco, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La radiografía de abdomen (Rx de abdomen) es en muchas ocasiones la prueba de imagen inicial en el estudio de la patología abdominal. Sin embargo, es una prueba cuyas indicaciones son muy concretas, ya que en muchas ocasiones están más indicadas la ecografía o la TC. Además debemos ser conscientes de los peligros que entraña la radiación, siendo especialmente dañina en el caso de los órganos reproductivos y pacientes jóvenes. Con estas consideraciones, en este capítulo vamos a valorar las proyecciones que debemos solicitar, cuándo debemos solicitar un Rx de abdomen, así como su lectura sistemática.

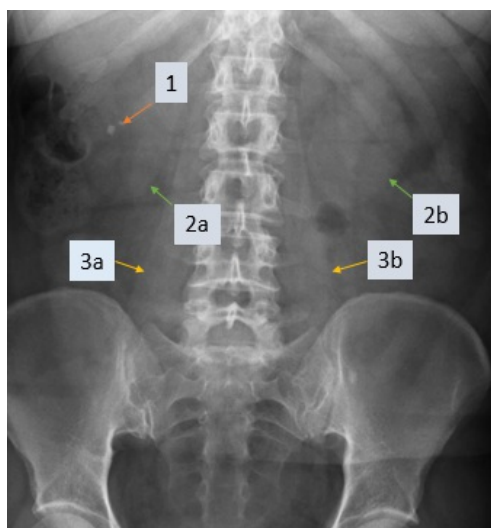
INDICACIONES

- Dolor abdominal agudo no filiado
- Sospecha de perforación. Realizar conjuntamente Rx de tórax
- Detección de cuerpos extraños y catéteres intrabdominales
- En cólico nefrítico refractario a tratamiento médico o seguimiento de cálculos
- Evolución de desobstrucción
- Control de desvolvulación

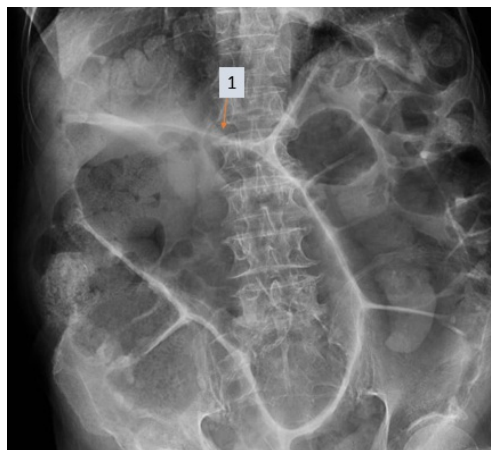
PROYECCIONES

La proyección estándar es en decúbito supino. Son proyecciones complementarias:

- **Rx en bipedestación:** se suele realizar si sospecha de perforación u obstrucción
- **Rx en decúbito lateral con rayo horizontal:** si bipedestación no tolerada.



Placa Rx simple decúbito supino: 1) litiasis renal derecha, 2a) silueta renal derecha, 2b) silueta renal izquierda, 3a) línea del psoas derecho, 3b) línea del psoas izquierdo.



Placa Rx simple decúbito supino: 1) vólvulo de sigma, con la imagen en grano de café ocupando la mayor parte del abdomen y con el eje hacia el hipocondrio derecho.

CALIDAD DE LA IMAGEN

Debemos asegurarnos que se incluyan ambos diafragmas, pelvis completa y caderas.

SISTEMÁTICA DE LECTURA

- **Visión global de la Rx:** vías, drenajes, sondas, clips quirúrgicos, DIU, etc.
- **Huesos:** esqueleto axial de arriba abajo (costillas, vértebras dorsales y lumbosacras, pelvis y cabezas femorales). Debemos fijarnos en cambios en el tamaño de cuerpos vertebrales (aplastamientos, Paget) o densidad (osteoporosis, lesiones blásticas), desplazamientos (escoliosis), líneas de fractura o luxaciones, lesiones líticas o blásticas (tumores óseos, metástasis, mieloma).
- **Contornos de los tejidos blandos:** La diferencia de densidad agua-grasa-agua permite identificar los contornos anatómicos de las estructuras abdominales. Reconocer visceromegalias, borramiento de líneas (del psoas, de los flancos) que es sugestivo de proceso inflamatorio, masas o líquido libre.
- **Patrón de gas abdominal:**
- Gas intraparietal o neumatosi intestinal: gas en la pared del intestino. En niños es patognómica de enterocolitis necrotizante, en adultos se relaciona con isquemia mesentérica.
 - Gas extraluminal o neumoperitoneo: casi siempre es patológico, aunque es frecuente y normal verlo tras una cirugía de abdomen o tras diálisis peritoneal. La causa más frecuente de neumoperitoneo espontáneo es la perforación de víscera hueca, siendo lo más frecuente por úlcera duodenal. Es de elección la proyección PA de tórax en bipedestación o decúbito lateral izquierdo si el paciente no aguanta la bipedestación.
 - Gas localizado en órganos: Neumobilia o gas en vía biliar, generalmente tras CPRE o por perforación de vesícula o colédoco hacia el tubo digestivo por un cálculo (fístula bilioentérica). Abscesos.
 - Gas intraluminal: se considera normal la presencia de aire en intestino, asas de delgado y colon. Podemos seguir la regla de 3/6/9. Es decir, niveles hidroaéreos normales en intestino delgado <3 cm, en colon <6 cm y en ciego <9 cm.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

- Íleo mecánico (obstrucción intestinal):
 - Obstrucción de intestino delgado: múltiples asas dilatadas, de disposición central. Los signos radiológicos son: distensión gaseosa proximal, niveles hidroaéreos, reducción o ausencia de gas en el colon, patrón en escalera, imagen en collar de perlas. Las causas más frecuentes son las adherencias o bridas. Hablamos de íleo ante un intestino aperistáltico, dilatado por causas no mecánicas.
 - Obstrucción de intestino grueso: El luminograma colónico tiene una localización periférica. La obstrucción se manifiesta como gran distensión de colon y ciego. Si la válvula ileocecal es competente no habrá distensión de asas de intestino delgado, no será así si la válvula es incompetente. La causa más frecuente es el carcinoma. Otras causas son hernias, vólvulos, diverticulitis. En el vólvulo de ciego y sigma se produce un estrangulamiento por torsión del intestino grueso sobre su propio eje. El segmento afecto se dilata. El vólvulo de sigma se observa como una burbuja que tiende a localizarse hacia hipocondrio derecho, el sigma pierde sus haustras y da una imagen de “grano de café”. El vólvulo de ciego, en cambio, forma una gran burbuja que tiende a localizarse hacia hipocondrio izquierdo o centro del abdomen.
- Íleo adinámico o paralítico:
 - Es la detención del tránsito intestinal sin que exista obstrucción mecánica, se trata de un problema funcional. Se manifiesta como una dilatación difusa de todo el tubo digestivo, intestino delgado y grueso, con presencia de gas distal. Tiene múltiples causas: cirugía abdominal, peritonitis, fármacos, trastornos hidroelectrolíticos (como ocurre en el síndrome de Ogilvie), etc. Calcificaciones: quiste hidatídico, a nivel de la vesícula (litiasis, vesícula en porcelana), pancreatitis crónica, riñones (nefrocalcinosis) , trayecto ureteral y vejiga (cálculos), tumores ginecológicos, liposarcoma.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología Esencial. SERAM. 1ªEd, Madrid: Médica Panamericana; 2011. p.393-410.
- Artigas JM, Martí M, Rodríguez C, et al. Radiografía del abdomen en urgencias. ¿una exploración para el recuerdo?. Radiología 2015;57:380-90 - DOI: 10.1016/j.rx.2015.06.002